

Dermatología Clínica Esencial: Acné y Rosácea

Masterclass detallada para estudio
clínico y preparación médica

Acné: Definición y Los 4 Pilares Fisiopatológicos

Clinical Flashcard

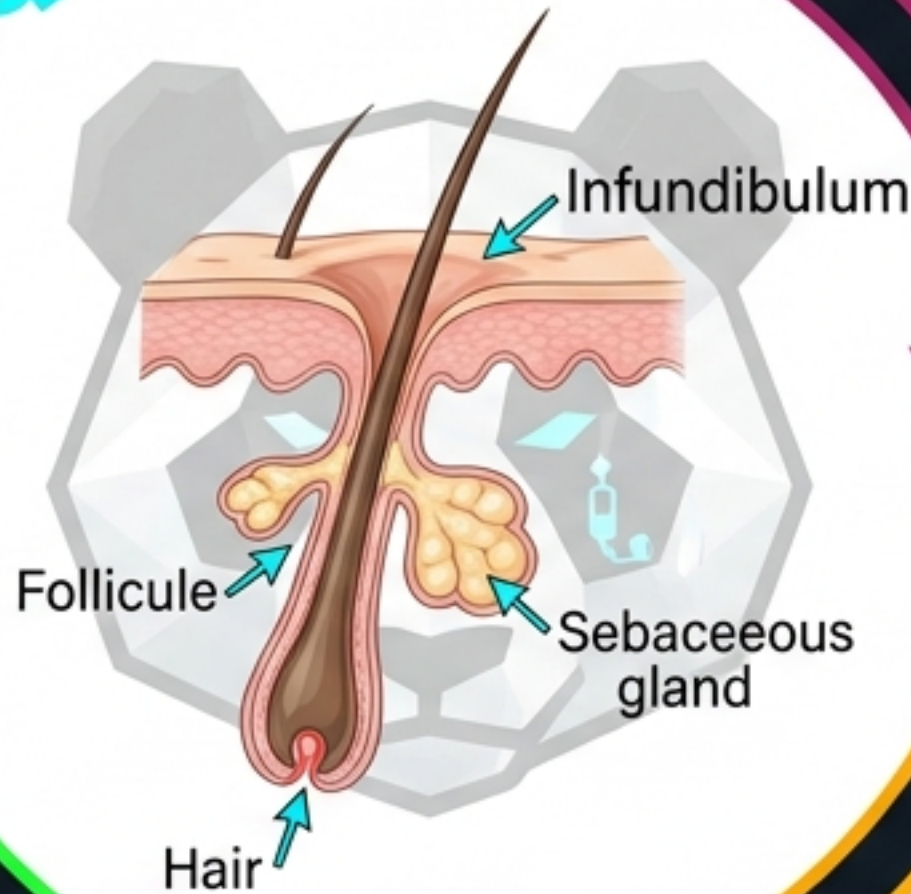
Enfermedad inflamatoria (no infecciosa) y crónica, expresada en **unidades pilosebáceas sensibles a andrógenos**.

4. Inflamación

Ruptura de la glándula sebácea
-> liberación de sebo en dermis
-> **respuesta inmune**
(Interleucina-1 alfa, migración de monocitos).

3. Microorganismos

Cutibacterium acnes.
Microorganismo comensal que forma una **biopelícula** (ecosistema resistente) y **promueve microcomedones**.



1. Herencia y Andrógenos

Herencia autosómica (50% de probabilidad si los padres padecieron).
Estímulo directo de andrógenos sobre sebocitos.

2. Sebo y Queratinización

Queratinización anormal del infundíbulo folicular (efecto embudo cerrado).
Disminución de ácido linoleico aumenta hiperqueratinización.

El Factor Endocrino y Síndromes Asociados

Vía Androgénica

Origen en damas: 50% de precursores circulantes, 50% corteza adrenal / estroma ovárico.

Testosterona

Dihidrotestosterona (DHT) (5 veces más potente)

Células blanco: Receptores androgénicos directos en sebocitos. (Nota: No siempre hay elevación de andrógenos séricos en acné común).

Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP)

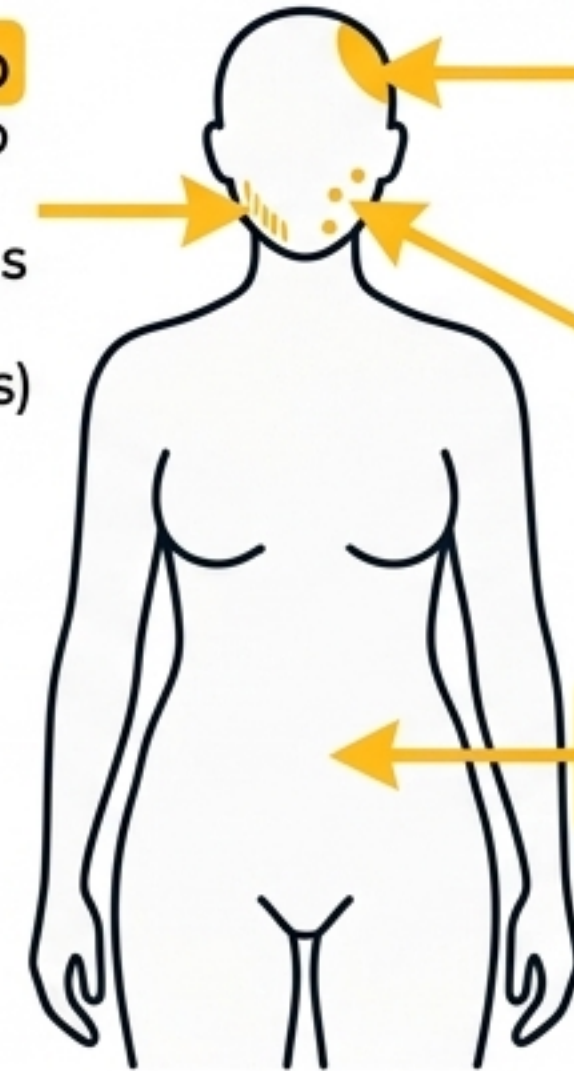
Afecta al 20% de mujeres en edad fértil.
Microquistes ováricos periféricos.

Hirsutismo
(crecimiento anormal de vello en zonas andrógeno-dependientes)

Alopecia androgenética

Acné severo

Obesidad abdominovisceral



Espectro Clínico: El Polimorfismo del Acné

POLIMORFISMO: Presencia **simultánea de múltiples tipos de lesiones en la misma área (cara, pecho, espalda)**. Diferenciador clave frente a otras dermatosis.



Lesión Característica: El Comedón
(No patognomónico, pero fundamental).

- Comedones abiertos (puntos negros).
- Comedones cerrados (espinillas/puntos blancos).

Impacto Psicosocial: Alto impacto emocional, ansiedad y depresión, independientemente del número de lesiones. Afectación extrafacial más grave en varones.



Lesiones Inflamatorias - Lesiones Inflamatorias

- Máculas y Pápulas eritematosas.
- Pústulas.
- Macrocomedones (indican mayor duración y resistencia al tratamiento).



Formas Severas y Cicatrización: Presencia de nódulos, quistes y lesiones con alto riesgo de secuelas cicatriciales permanentes (hipo/hipertróficas).

Formas Graves y La Tétrada de Oclusión Folicular

Acné Fulminans:

Forma excepcionalmente rara, compromiso del sistema inmune, alta mortalidad, requiere manejo sistémico urgente.

Acné Conglobata



Forma noduloquística severa. Nódulos que se unen en dermis, dermis, múltiples comedones, abscesos interconectados, cicatrices graves.

Celulitis Disecante

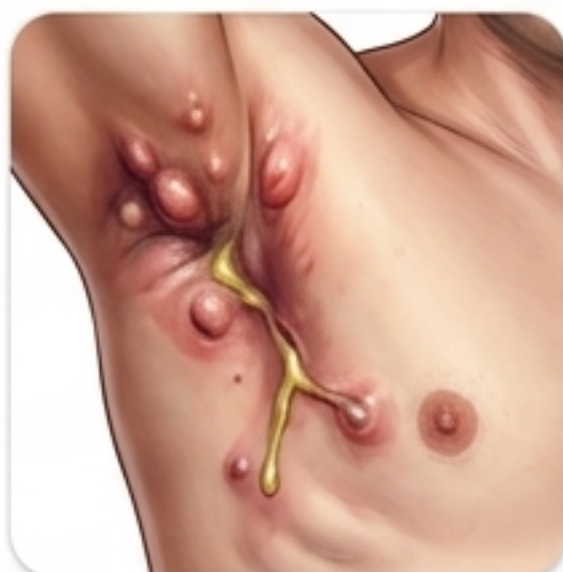


(Perifoliculitis capitis). Nódulos inflamatorios en cuero cabelludo, alopecia cicatricial (destrucción del folículo).



BADBEAR.MED
Panda Logo

Hidradenitis Suppurativa



Proceso inflamatorio (no infeccioso bacteriano primario) en grandes pliegues (axilas, ingles) con abundante exudado.

Quiste Pilonidal



Fístulas en región sacrococcígea, común en varones adolescentes velludos. Requiere fistulectomía.

Formas Especiales e Inducidas (Presentación Monomorfa)

REGLA DIAGNÓSTICA: A diferencia del acné común, el acné inducido suele presentar lesiones monomorfas (todas en la misma etapa de desarrollo).



Acné Neonatal

Pápulas eritematosas monomorfas en recién nacidos.

Manejo: Desaparece solo en 4-5 semanas sin tratamiento. Solo hidratación suave.



Acné Mecánico / Cosmético

Por oclusión física (**roce del cuello**) o química (vaselina). Cierra el ducto sebáceo.



Acné Inducido por Fármacos

- **Corticoides:** Muy frecuente (ej. Prednisona 15mg/día por 7-12 días). Pápulas eritematosas idénticas.

- **Cianocobalamina** (Vitamina B12): Pústulas monomorfas agudas.



Elastoidosis a Quistes y Comedones

En pacientes mayores por daño solar extremo. Alteración del colágeno atrapa el sebo. Quistes y comedones en zonas perioculares/malares. Resistente a tratamiento tópico.

Matriz de Diagnóstico Diferencial del Acné

Patología	Tipo de Lesión	Rasgo Diferenciador Clave	Localización Principal
Acné Vulgar	Polimorfo (Comedones, pápulas, pústulas)	Presencia de comedones	Cara, pecho, espalda.
Dermatitis Seborreica	Pápulo-escamativa	Eritema con descamación fina, sin comedones	Región centrofacial, cejas, surcos nasogenianos.
Foliculitis de la Barba	Pústulas foliculares	Infección activa (<i>S. aureus</i> coagulasa positivo)	Área de la barba.
Dermatitis Periorificial	Pápulas/Pústulas monomorfas	Deja un halo de piel sana alrededor del borde del labio	Alrededor de cavidad oral, nariz, ojos.
Esclerosis Tuberosa	Angiofibromas monomorfos	Enfermedad genética, tumores benignos vascularizados	Centrofacial (simula acné resistente)

Escalera Terapéutica Médica del Acné

El Gold Standard: Isotretinoína

Actúa sobre todos los factores patogénicos (excepto herencia).
Advertencia Crítica:
Altamente teratogénico. Exige control hepático.
Embarazo estrictamente prohibido.

Sistémicos - Hormonales (Damas)

- **Acetato de Ciproterona:** Antagonista androgénico. Riesgos: Hepatotoxicidad, meningioma.
- **Espironolactona:** Diurético ahorrador de potasio, bloquea receptores. Dosis progresivas.

Sistémicos - Ciclinas (Eficacia en declive)

Minociclina, Doxiciclina.
Dirigidas contra *C. acnes*. Uso decreciente por resistencia y alteración de microbiota.
Contraindicado < 12 años y embarazadas.

Tópicos (Acné Leve/Comedónico)

Peróxido de benzoílo, Ácido salicílico, Ácido azelaico.
Retinoides tópicos
(Tretinoína, Tazaroteno).
Antibióticos (Clindamicina 1%, Eritromicina 2-4%).

BADBEAR.MED
Panda Logo

BADBEAR.MED

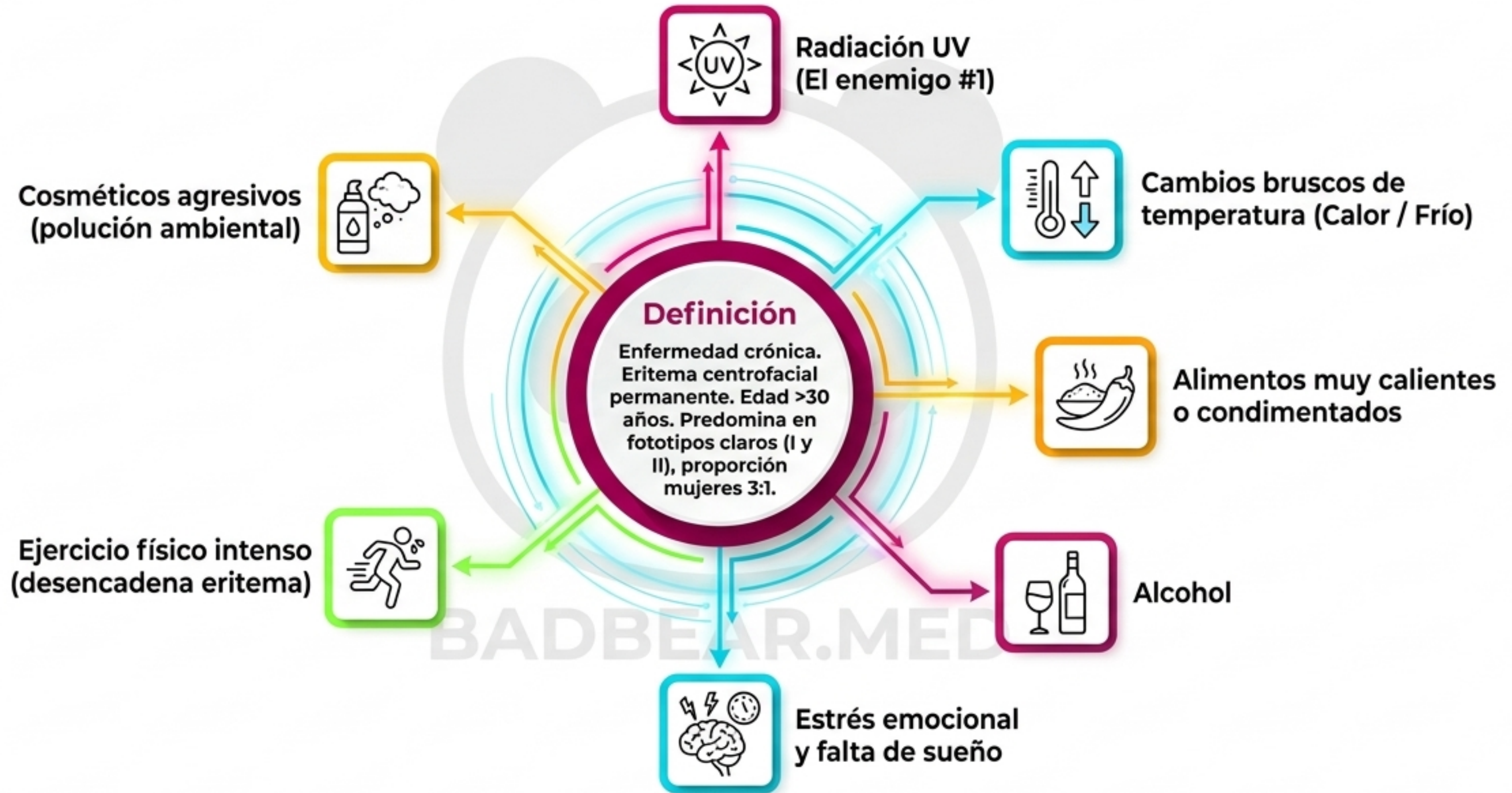


Manejo de Secuelas y Cicatrices Atróficas

Concepto: Las cicatrices atróficas (ej. picahielo) son extremadamente difíciles de revertir. Las expectativas del paciente deben ser manejadas (mejoría del 50-80%, nunca 100%).

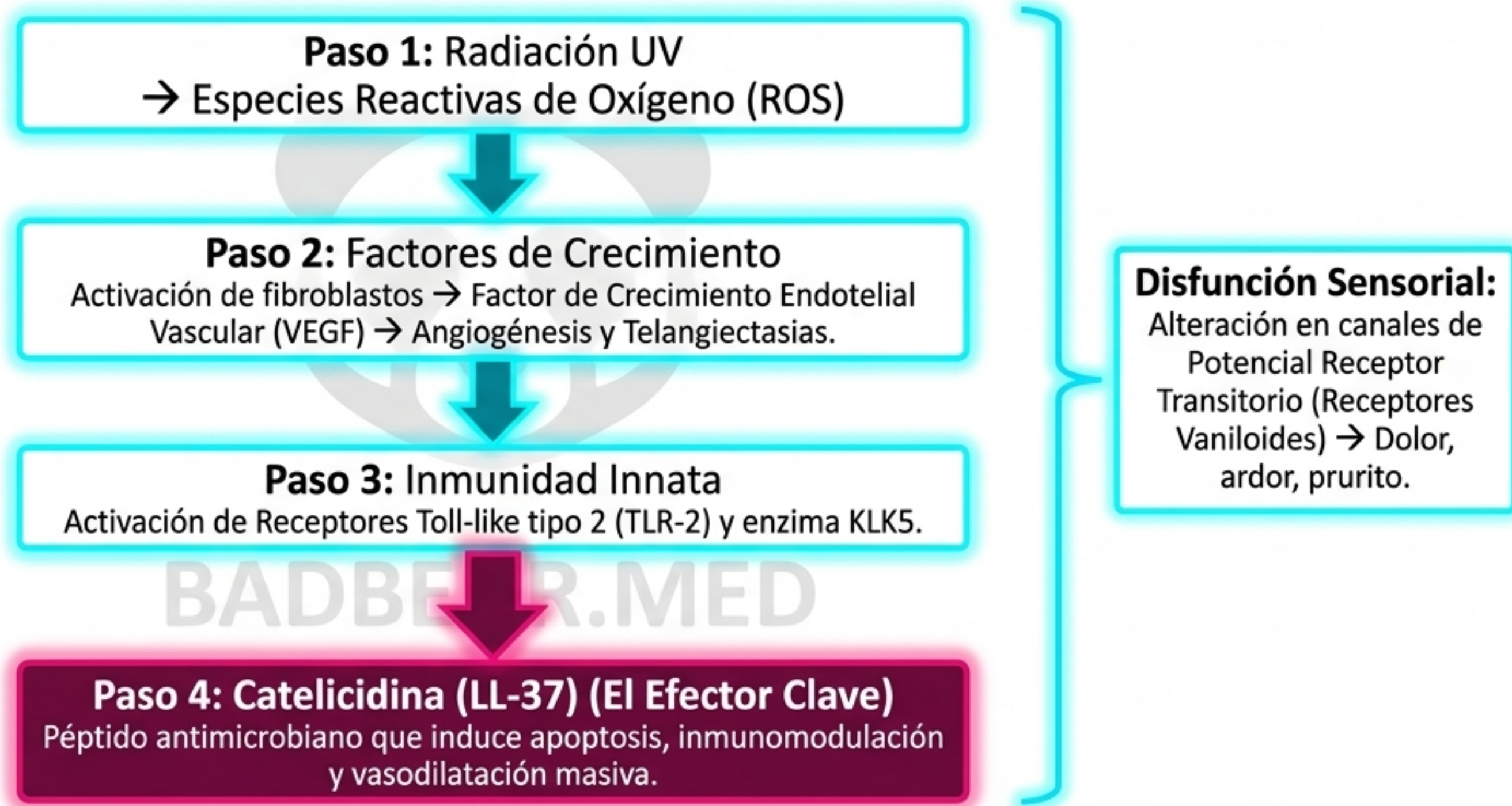
Alta Eficacia / Mayor Rendimiento	Baja Eficacia / Pobre Rendimiento
 - Subcisión: Uso de aguja con filo para romper tractos fibrosos. Combinada con relleno de Ácido Hialurónico.  - Peeling Químico Profundo: Ácido Tricloroacético (TCA) al 30-50%. Produce necrosis epidérmica/dérmica papilar.  - Microinjertos / Punch: Sacabocados para retirar la cicatriz y suturar (Nylon 6-0) o colocar injerto.  - Láser CO2 No Fraccionado: Remodela colágeno agresivamente.	 - Criocirugía: Nitrógeno líquido. Resultados muy pobres para cicatrices de acné.  - Microdermoabrasión: Fresas a alta velocidad. Solo remueve estrato córneo; ineficaz para dermis.  - Microneedling (Dermapen): Generación de nuevo colágeno clínicamente dudosa para atrofia severa.

Rosácea: Definición y El Eje del Exposoma



Fisiopatología de la Piel Sensible y Reactiva

Concepto Core: Excesiva reactividad a factores externos con disfunción de la capa córnea y neurosensorial.



Clasificación Clínica de la Rosácea

1. Eritematotelangiectásica



Eritema centrofacial persistente, múltiples telangiectasias, episodios de flushing (rubor), sensibilidad extrema.

2. Pápulo-Pustulosa



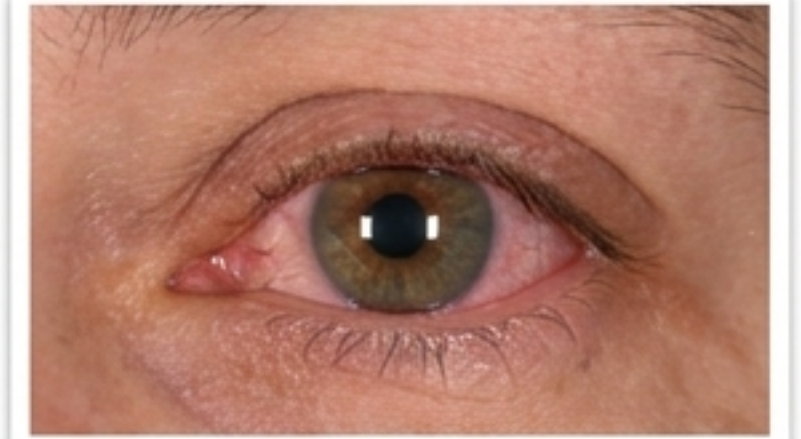
Eritema de base con pápulas y pústulas simulando acné.
Diferencia Clave: Ausencia total de comedones. Altamente recidivante.

3. Fimatosa (Rinofima)



Estadio hipertrófico tardío, glándulas sebáceas engrosadas, distorsión anatómica (comúnmente en pirámide nasal de varones).

4. Ocular / Granulomatosa



- **Ocular:** Hiperemia conjuntival, síndrome de ojo rojo. Requiere derivación obligatoria al oftalmólogo.
- **Granulomatosa:** Rara, pápulas/nódulos duros en rostro.

Matriz de Diagnóstico Diferencial de la Rosácea

Patología	Hallazgo Clínico Distintivo	Notas Fisiopatológicas
Demodicosis	Caspa/collares en la base de las pestañas, prurito, lagrimeo	Demodex folliculorum y brevis intervienen promoviendo VEGF, pero no son el factor predominante único. Requiere biomicroscopio.
Dermatitis Seborreica	Placas eritemato-escamativas en cejas, cuero cabelludo	Altamente exacerbada por estrés. Puede coexistir con rosácea.
Rebote por Corticoides	Empeoramiento masivo (pústulas/eritema) a los 5 días de suspender	Los corticoides tópicos/sistémicos mejoran inicialmente pero causan dependencia y rebote grave. Totalmente contraindicados.

BADBEAR.MED



Protocolo de Manejo BADBEAR.MED para Rosácea

La Base: Educación estricta del paciente.
Uso innegociable de fotoprotector y
cosmética para piel sensible.

Rama Tópica

- **Metronidazol** (0.75 - 1%) en gel, loción o fórmula.
- **Ácido Azelaico** (5% - baja concentración).
- **Tacrolimus** (Inhibidor de calcineurina en pomada).
- **Adapaleno** (0.1% - Tiempos cortos de contacto, 30-60 min, para evitar irritación).
- **Ivermectina / Clindamicina 1% / Eritromicina 2-4%.**



BADBEAR.MED
Panda Logo

Rama Sistémica y Física

- **Tetraciclinas:** Usadas a dosis antiinflamatorias, no antibacterianas.
- **Isotretinoína:** Dosis bajas, alta eficacia.
- **Propranolol:** Betabloqueante para controlar el flushing y eritema vascular.
- **Electrocirugía:** Coagulación mínima sin anestesia para eliminar telangiectasias faciales.

Matriz Maestra de Síntesis: Acné vs. Rosácea

Dimensión Comparativa	Acné Vulgar	Rosácea
Edad de Inicio	Pubertad / Adolescencia	>30 años
Fisiopatología Primaria	Sebo + Queratinización + Andrógenos + C. acnes	Reactividad vascular + LL-37 + VEGF + Angiogénesis
Lesión Característica	Comedón (Polimorfismo clínico)	Eritema centrofacial + Telangiectasias (Ausencia de comedones)
Zonas Afectadas	Cara, Pecho, Espalda (Extrafacial)	Exclusivo facial (Rara vez extrafacial), Ocular
Relación con el Sol	El daño solar extremo causa variantes retencionales	El Sol es el desencadenante principal (#1 Exposoma)
Pilar Terapéutico	Retinoides, Isotretinoína a dosis plenas	Metronidazol, Evitar triggers, Isotretinoína a dosis bajas